Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 34ª Vara Cível da Capital

, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810520

Processo nº 0073659-05.2023.8.17.2001

AUTOR(A): ANA HELOISA GONCALVES ESCARIAO

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por ANA HELOISA GONÇALVES ESCARIÃO, em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, todos qualificados e representados.

Aduz, em síntese, ser portadora de Carcinoma Renal Metastático (CID C64); que ouviu a opinião de um segundo oncologista, Dra. Carolina Matias, CRM PE 14.693, que prescreveu necessita a autora *ser submetida a um novo tratamento, com melhor perfil de tolerabilidade, por meio do uso da medicação PAZOPANIB (VOTRIENT), na dose de 400 mg, via oral, 02 vezes ao dia (DOSE TOTAL 800 mg AO DIA), de forma contínua*; que o plano de saúde Réu negou cobertura para o tratamento sob o argumento de que seu contrato não dá direito a essa cobertura. Juntou guia de validação prévia com negativa (Id. 137425289 - Pág. 1) e cláusulas gerais do contrato (Id. 137424179) e comprovante de recolhimento de custas (Id. 137462642).

Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja o plano de saúde réu compelido a autorizar, em caráter de urgência, o medicamento PAZOPANIB (VOTRIENT) conforme prescrição médica.

No mérito, requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),

Decisão de indeferimento liminar da antecipação da tutela (Id. 137492304).

Decisão, em sede de agravo de instrumento, tombado sob o n. º 0013617-42.2023.8.17.9000, da 1ª Câmara Cível - Recife em que deferido o pedido de tutela de urgência (Id. 139381286).

A parte autora alegou descumprimento da decisão do Tribunal (Id. 139303538), ao quer a parte ré respondeu, no Id. 140124062, informado estar diligenciando e, posteriormente, juntou aos autos documento que comprova a entrega do medicamento (Id. 141128933

Oportunamente foi apresentada contestação (Id. 141302459) na qual sustenta que o contrato objeto da demanda é antigo, anterior a lei nº Lei nº 9.656/98 e, portanto, as limitações de cobertura são aquelas contratualmente discriminadas; que o contrato da exclui expressamente as despesas com medicamento de uso domiciliar; e que a apólice em questão não foi adaptada à Lei 9656/98.

Houve réplica (Id. 154174958).

As partes não pugnaram pela produção de mais provas.

É o breve relatório.
Passo a decidir.

O cerne da questão posto em análise é decidir se tem a parte ré obrigação de dar cobertura a tratamento com medicamento par auso domiciliar - Teriparatida (Forteo 250 mg) - de conformidade com as cláusulas contratuais, considerando-se, também, o conteúdo da Lei 9.656/98.

No que diz respeito à cobertura contratual dos contratos celebrados anteriormente à Lei 9.656/1998, estabelece a legislação o seguinte:

Lei 9.656/1998:
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(...)
§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
(...)
§ 7º Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas.

Em todos os pareceres da ANS que dizem respeito à cobertura obrigatória dos contratos novos consta a seguinte observação:

Por fim, é relevante salientar que, no caso de planos antigos não adaptados (planos contratados até 01/01/1999 e não ajustados à Lei n.º 9.656/1998, nos termos de seu art. 35), a cobertura ao procedimento em análise somente será devida caso haja previsão nesse sentido no respectivo instrumento contratual. (PARECER TÉCNICO Nº 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 COBERTURA: MEDICAMENTOS.)

É dizer, a Lei 9.656/1998 instituiu o plano de saúde referência de assistência à saúde, bem como estabelece que o Rol de Eventos em Saúde da ANS é a referência mínima de cobertura dos planos de saúde. E, para aqueles contratos de seguro saúde que foram celebrados antes da vigência da Lei de Planos de Saúde e a ela adaptados, dispõe a lei que a cobertura está prevista no contrato, não estando o plano de saúde obrigado a autorizar às suas expensas o que não estiver contratualmente previsto.

No caso dos autos, é incontroverso o fato de ser a apólice anterior à Lei 9.656/98 e a ela não adaptada.

O plano de saúde réu defende a legalidade da negativa de autorização sustentando-se na exclusão contratual. Observo, no entanto, que o contrato não exclui expressamente o tratamento objeto da demanda. Em assim sendo, é de meu entendimento que, no caso de contrato anterior à lei de referência e a ela não adaptado, se não há expressa exclusão, deve ser aplicado o Rol da ANS.
Todavia, ainda que analisado o caso dos autos adaptando o contrato à Lei 9.656/1998, a ação é improcedente. Senão vejamos.

A Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 10º institui o **plano-referência de assistência à saúde** e estabelece que a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela Agência Nacional de Saúde - ANS.

O referido rol, cujas regras encontram-se atualmente estabelecidas pela Resolução Normativa – RN nº 465, de 2021, estabelece uma lista de procedimentos e exames taxativa.

O rol de procedimentos é revisado com a participação de um grupo técnico composto por representantes de entidades de defesa do consumidor, de operadoras de planos de saúde, de profissionais de saúde que atuam nos planos de saúde e de técnicos da ANS.

Isso não significa que todos os planos estão limitados a cobrir apenas o que consta na Resolução Normativa referida, mas sim que tratamentos/procedimentos adicionais deverão constar expressamente no contrato.

É dizer, o Rol de Eventos em Saúde da ANS não é meramente exemplificativo.

Registro que a lei nº 9.656/98 foi modificada para incluir no art. 10º os parágrafos 12 e 13 com **as hipóteses e requisitos para cobertura obrigatória de procedimentos e tratamentos não constantes do rol**, vejamos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente julgamento do EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704, decidiu que o rol de procedimentos obrigatórios da ANS **não deve ser visto como meramente exemplificativo** e fixou a seguinte tese:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;
***2 -** a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;*
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:
(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;
(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e
(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso concreto, a Segunda Seção, por unanimidade, ainda que por fundamentação diversa, negou provimento aos embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Nesse ponto, importa ressaltar que embora caiba ao médico assistente a decisão acerca do melhor tratamento, e conquanto haja tal liberdade, não se pode exigir da prestadora de serviços médicos que seja incumbida do pagamento de tratamento que, não estando previsto no contrato celebrado, nem no Rol da ANS.

Nesse sentido, os enunciados 21 e 23 da I Jornada de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça instrui os magistrados a:

Enunciado n.º 21
Nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n.o 9.656/98, recomenda-se considerar o rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas.
Enunciado n.º 23
Nas demandas judiciais em que se discutir qualquer questão relacionada à cobertura contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, recomenda-se a consulta, pela via eletrônica e/ou expedição de ofício, a esta agência Reguladora para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio.

O tratamento prescrito para a parte autora, entretanto, não está previsto no Rol da ANS como de cobertura obrigatória para os planos de saúde submetidos à lei de referência. Com efeito, o PAZOPANIB (VOTRIENT) não está incluído no item 64, do anexo II - Diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar, que elenca as terapias antineoplásicas orais para tratamento do câncer (https://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/Anexo_II_DUT_2021_RN_465.2021_tea.br_RN473_RN477_RN478_RN480_RN513_RN536_RN537_RN538_RN539_RN540_RN541_RN542_RN544_546_550_553_571v2_575_576_577_578.pdf
(https://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/Anexo_II_DUT_2021_RN_465.2021_tea.br_RN473_RN477_RN478_RN480_RN513_RN536_RN537_RN538_RN539_RN540_RN541_RN542_RN544_546_550_553_571v2_575_576_577_578.pdf)).
Dessa feita, nem por força do contrato objeto da demanda, nem por força da submissão ao Rol obrigatório de eventos em Saúde, está a parte Demandada obrigada a custear o tratamento objeto da demanda pois não previsto no contrato e fora do Rol da ANS.

Ressalto, não há nos autos comprovação de situação fática a atrair a exceção, estabelecida pela decisão do superior Tribunal de Justiça, em relação à taxatividade do rol de eventos em saúde da ANS, já que a parte demandante não trouxe as evidências cientificas e o plano terapêutico ou comprovou a recomendação da Conitec ou de órgão internacional para o procedimento solicitado, a ensejar a mitigação de obrigatoriedade do rol da ANS, sendo inviável ao magistrado que não possui conhecimento técnico, discernir tais questões.

Ressalto, como já dito, que embora caiba ao médico assistente a decisão acerca do melhor tratamento, e, conquanto haja tal liberdade, não se pode exigir da prestadora de serviços médicos que seja incumbida do pagamento de tratamento que, não estando previsto no contrato celebrado, nem no Rol da ANS, não é o único tratamento possível para o paciente. Se for o caso de preferência do paciente e de sua equipe médica por tratamento que julgam melhor, é o caso de o beneficiário do plano de saúde arcar com o custo de sua escolha, tendo em vista a taxatividade do Rol da ANS, o equilíbrio contratual e a força vinculante dos contratos.

No que diz respeito ao pedido de reparação civil, reconhecida a licitude da recusa da operadora, fica igualmente afastada a compensação por danos morais, julgo IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais.

E, embora não constatada nenhuma abusividade do plano de saúde réu no caso dos autos, não é demais trazer à baila o entendimento do intérprete da Lei Federal (no caso a Lei 9.656/1998) para situações como a dos autos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUSA FUNDAMENTADA EM REQUISITOS DE ATO NORMATIVO DA ANS. DANO MORAL. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O STJ já decidiu que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.
2. A despeito do reconhecimento do dever do plano de saúde de cobrir as despesas da cirurgia em virtude da existência de indicação médica,não é possível reconhecer que a recusa da operadora agravada, devidamente pautada por ato normativo da ANS, caracterize ilícito gerador de dano moral.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1645135/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017)

Isto posto, com base nos dispositivos legais antes mencionados, **julgo improcedentes** os pedidos formulados na inicial e extingo o processo com julgamento do mérito, com fundamento no Art. 487, I, CPC.

Condeno a parte AUTORA no pagamento da verba honorária de 10% sob o valor atualizado da causa.

Publique-se. Intimem-se. Preenchidos os requisitos legais, arquivem-se.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Juiz(a) de Direito
34vcb1

Assinado eletronicamente por: CLAUDIO MALTA DE SA BARRETTO SAMPAIO
23/07/2024 11:25:46
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 176492034

24072311254609400000172255910

IMPRIMIR GERAR PDF